



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 12-10-2024 14:33:06

Página 1 de 4

Información Paciente			N° Epicrisis	
Nombre	: Alfonso Daniel Guarda Sepulveda	Rut	: 16.091.928-0	N° Archivo : 9841382
Edad	: 39a 4m 14d	Fecha Nacto:	28/05/1985	Sexo : Masculino
Dirección	: Los Ciruelos 35 Villa Los Cantaros	Comuna	: Puente Alto	Teléfono : 9 4259 0021

Información Hospitalización			
Unidad de Ingreso	: Medicina Agudos (4tp Piso)	Fecha Ingreso	: 02/10/2024 23:31
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 12/10/2024 14:10
		Días Estadía: 10	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso
DIFICULTAD RESPIRATORIA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico
EPÍCRISIS.

Alfonso Daniel Guarda Sepúlveda
RUT: 16.091.928-0
Edad: 39 años
Fecha Ingreso CASR: 02/10/2024
Fecha Ingreso UTIM: 03/10/2024
Fecha Ingreso UPC: 11/10/2024
Fecha egreso UPC.
ESTADO : FALLECIDO.

ANTECEDENTES:

Médicos: Ca pulmón (adenocarcinoma acinar) operado en 01/2022 sin QT-RT en Clínica Red Salud Vitacura. PET y RM de cerebro sin diseminación (12/2021) Retoma controles en 2023, caso discutido en equipo de broncopulmonar en contexto de deterioro funcional, TC 11/2023 con adenopatías en hilio pulmonar izquierdo subcarinal, en plan de PET CT para reetapificar y definir abordaje para nueva BP. Nuevo PET CT (2024) con adenopatías hiliares, mediastínicas, pericardiofrénicas, crural izquierda en plan de biopsia mediastínica por EBUS. RM (-) En estudio por sospecha de recidiva. Biopsia (23/07) confirma adenocarcinoma acinar de pulmón (PD-L1 50% positivo, CK 7, TTF-1 Napsina positivas). Posterior a EBUS evoluciona con disnea y dolor torácico con tope inspiratorio, con DP (exudado mononuclear maligno) y neumotórax laminar iatrogénico, se deja pleurostomía fina (14/08), alta con válvula de Heimlich (estuvo hospitalizado en 08/2024). Con pérdida accidental de drenaje re evaluado por equipo de cirugía de tórax sin indicación de nuevo drenaje (evaluación en ambulatorio). En último control con oncología, en plan de nuevo control con estudio molecular para definir terapia. Ingresado a CCPP en manejo con parches de buprenorfina y clonazepam.

ERC etapa V en HD trisemanal (Trinef 3° turno) por FAV BI, etiología desconocida. Monorreno quirúrgico (donante de riñón)

Medicamentos: Carbonato de calcio. EPO semanal.

Quirúrgicos: Lobectomía LII (01/2022). Donante de riñón. OTS ortejo y rótula derecha. Cervicotomía exploradora + venorrafia por herida penetrante cervical derecha (2012)

Alergias: No conocidas

Fecha Epicrisis : 12/10/2024 14:33

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 12-10-2024 14:33:06

Página 2 de 4

Hábitos: OH: (-) Tabaco: (-) Drogas: THC suspendida?

Social: Autovalente, vive con esposa e hijos. ECOG 1

HISTORIA CLÍNICA

Paciente con antecedentes mencionados, el día 26/09 evaluado por equipo en ambulatoria por retiro de drenaje pleural, asintomático, sin indicación de nuevo drenaje. Paciente consulta en SU el 02/10 por disnea progresiva hasta mínimos esfuerzos, asociado a dolor en hemitórax derecho, sin tope inspiratorio. Niega fiebre, sin tos con expectoración, sin otra sintomatología asociada. Ingresa vigil, orientado en tiempo y espacio, hipotenso (99/68 mmHg), taquicárdico (119 lpm), afebril, saturando 92% con 2L por NRC. En examen físico destaca bien hidratado, bien perfundido, a nivel pulmonar con MP abolido en ambas bases, Se realiza US sin líneas B, derrame pleural bilateral, impresiona loculación en DP izquierdo

Exámenes de Laboratorio (02/10): BUN 60, ELP 138/5.8/94, HB 10.9, GB 13480 PQ 576.000, PCR 324, INR 1.23, PH 7.34 HCO3 48 PCO2 48

TC Tórax (02/10): Cambios postquirúrgicos de lobectomía inferior izquierda. LSI colapsado con múltiples atelectasias subsegmentarias y segmentarias, con leve engrosamiento difuso de pleura visceral. Parénquima pulmonar aireado con engrosamiento septal interlobulillar liso LSI, con múltiples opacidades parenquimatosas peribroncovasculares. Moderado DP derecho mayor a estudio previo. Leve-Moderado DP izquierdo con leve hidroneumotórax, con engrosamiento e hiperrealice de pleuras. Múltiples adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales destacando conglomerado laterotraqueal izquierdo de 19 mm y uno pequeño infracarinal de 27 mm. Adenopatías axilares bilaterales hasta 17 mm a derecha y 12 mm a izquierda.

Ingresa a UTIM donde se pesquiza FAV semitrombosada con disfunción de esta en la diálisis por lo que inicia anticoagulación, Se realiza drenaje de 800 cc de liquido pleural en urgencia con lo que mejora en forma importante su disnea y la mecánica Infecioso. El día 4/10 se instala pleurostomía, cultivos de ambas punciones, el primero sin valores compatible con empiema pero con cultivo con S Epidermidis MS, el segundo con cultivo nega tivo pero ph 7.0 y glucosa baja inicia terapia con Tazonam que llega a completar 9 días. Evaluado por infectología se decide cambiar a cefazolina + metronidazol el día 9/10 que no llega a completar 24 hrs cambiándose a vancomicina+ meropenem por deterioro progresivo del cuadro clínico. Tiene cultivos pendientes del 09/10

Respiratorio. Mejoría con la instalación de pleurostomía el día 4/10, El 8 por disminución del débito se permeabiliza y se deja aspirativo con lo cual vuelve a funcionar

Aumento de los requerimientos de oxígeno asociado a hipotensión tras instalación de tunelizado el 9/10. Ddao compromiso hemodinámico y mala mecánica se decide intubar el 10/10 en la madrugada, sedándose y dejando ventilación protectora Actualmente con compliance de 15, DP de 20 con asimetría importante a la ventilación, torax izq casi no se mueve al ventilar, por lo que se mantiene a 6ml/hr de VC

Hemodinamia: Inicia vasoactivos en la tarde posterior a instalación de tunelizado en pabellón, se descarta neumotorx y sangramiento como causa, rápidamente va al deterior tanto hemodinámico como respiratorio. Se decide realizar hemodiálisis que no tolera. Finalmente post intubación se inicia doble vasoactivos, con noradrenalina a 0.5 y vasopresina por lo que se decid hemodiafiltración continua con lo que a las 5 hrs tiene suspendida la vasopresina y noradrenalina a 0.3, último control de lactato en 1.1

Renal: Paciente monorreño quirúrgico, falla renal de etiología desconocida, en HD trisemanal por FAV que se trombosa en esta hospitalización, subdializado se decide instalar tunelizado previa autorización de infectología lo que se realiza el 9/10. Actualmente en hemodiafiltración por shock refractario, con buena respuesta, por lo que se descontinúa a las 5 hrs y se baja a UPC se completaran a lo menos 12 hrs. Reevaluar en ese momento

Oncológico: Adenocarcinoma acinar de pulmón metastásico, pendiente estudio molecular para definir terapia de rescate

EXAMEN FISICO

Sedado con fenta+dormonid

Hemodinamia PA 100/48 con noradrenalina a 0.4

Saturando 99% con FIO2 al 35

FC 96x/1

Bien perfundido

Pupilas mióticas simétricas

Yugular der ++, aposito seco supraclavicular izq, tunelizado a izq

Asimetría torácica con hemitórax izq casi sin movimiento y silencio pulmonar, pleurostomía a derecha dando seroso

RR2TSS

ABD BD

Ext CVC femoral derecho

Diagnósticos de Ingreso

1.-Insuficiencia Respiratoria aguda

Fecha Epicrisis : 12/10/2024 14:33

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 12-10-2024 14:33:06

Página 3 de 4

- Cancer de pulmón operado recidivado
- Derrame pleural derecho-Empiema
- 2.-Insuficiencia Renal en HD
 - Instalación de tunelizado el 9/10
 - FAV Trombosada
 - Monorreno quirúrgico
- 3.-Shock séptico refractario
 - S Epidermidis en liq pleural con ph 7.0
- 4.-Obs coagulopatía como Sd paraneoplásico

EVOLUCION EN LA UPC.

Paciente que es traslado de la UTIM-. Durante dicho traslado se suspende HFAV en forma temporal.

Neurologico: se mantiene bajo sedacion en SAS 1, bien adaptado.

HDN: con altos requerimientos de DVA, sin mejoría luego del uso de HFAV. Por lo que luego de las 24 horas cumplidas, se suspende procedimiento para valorar.

Respiratorio: en el contexto de TU pulmonar izquierdo operado, paciente con paquipleuritis y fibrosis pulmonar que evidencia pulmón izquierdo poco expandible. Ventilación mecánica muy dificultosa ddo altas presiones de vía aérea. Se mantiene con ventilación ultraprotectora.

Renal: con falla renal en HD. Dado compromiso hemodinámico se define inicio de HFAV, se cumple 24 horas de apoyo, sin evidencia de beneficio. Por tal motivo se suspende.

Metabólico: en seguimiento.

Digestivo: dada condición hemodinámica y gravedad del paciente se mantiene en régimen cero.

Paciente evoluciona en shock interpretado como séptico, refractario a todo tratamiento. Se agrega Falla multiorgánica.

Inicia PCR en asistolia, iniciándose RCP avanzado sin respuesta.

Se declara fallecido el 12.10.24 a las 14:10hs.

Se entrega certifica de defunción.

Diagnóstico de Egreso

Choque séptico -
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECE

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



José Alfredo Cadena Orta

Fecha Epicrisis : 12/10/2024 14:33

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA

Fecha Última Actualización: 12-10-2024 14:33:06

INTERNO

Becado/Residente



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Página 4 de 4

Médico Tratante (Staff)